BỆNH LAO NGHỀ NGHIỆP

PGS.TS. Trần Như Nguyên BSCK II

trannhunguyen2017@gmail.com

MỤC TIÊU

1/. Nêu được

- yếu tố căn nguyên
- đường lan truyền
- đối tượng lao động có nguy cơ mắc

2/. Nêu biểu hiện bệnh - chẩn đoán - điều trị

3/. Nêu các giải pháp dự phòng

NỘI DUNG

- Mở đầu
- Căn nguyên
- Đường lan truyền
- Đối tượng lao động có nguy cơ mắc
- Ảnh hưởng sức khỏe chủ yếu
- Chẩn đoán
- Điều trị
- Giải pháp dự phòng

1. Mở đầu

Bệnh lao hiện nay

Bệnh lao nghề nghiệp

(là 1 trong những BNN được BH ở Việt Nam)

TTLB 29/1991

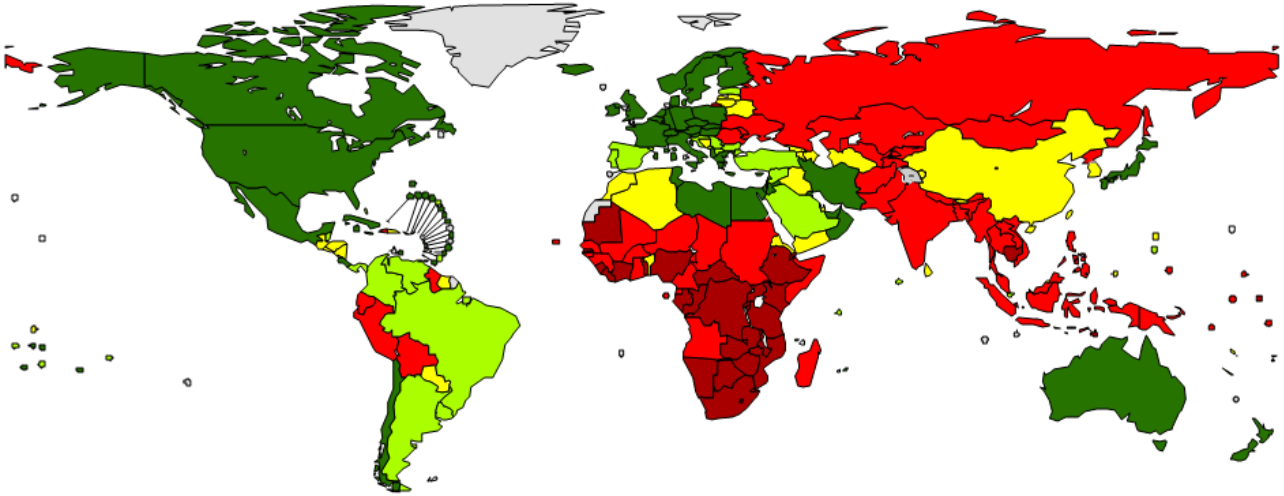
TT 15/2016-BYT/31

DỊCH TỄ HỌC

- Lao là một bệnh truyền nhiễm, y học nói đến hàng nghìn năm trước
- Rất dễ lây từ người này qua người khác.
- Một người bị lao có thể lây truyền cho 10 - 15 người khác trong một năm.
- Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hội nghị quốc tế về lao lần thứ tư họp tại Mỹ (tháng 6/2002), trung bình mỗi năm trên toàn thế giới có ít nhất trên 2 triệu người tử vong do lao và khoảng 8 triệu người bị mắc lao.
- Trong vòng 10 năm (1990-2000) đã có gần 30 triệu trường hợp tử vong do lao.

- Vào giữa thế kỷ 20, việc tìm ra kháng sinh và một số thuốc hóa học chữa lao đặc hiệu nên tình hình mắc lao có giảm=> ngành Y tế nhiều quốc gia chủ quan lơ là trong phòng chống lao
- Cuối thập kỷ 90, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo: bệnh lao có chiều hướng tăng trở lại, nhất là ở những nước đang phát triển
- Thêm những nguy cơ mới như kháng thuốc tăng, lao+nhiễm HIV/AIDS tử vong nhanh
- Hội nghị Tokyo (2019) đang diễn ra …

Phân bố số người bệnh lao mới mắc ước tính/100.000 dân, ở các quốc gia



Số lượng-Tỷ lệ-Phân bố

- 9.2 triệu người mới mắc lao
- 1.7 triệu người chết do lao
- Tỷ lệ cao nhất ở châu Phi
- Trong số mắc Lao trên thế giới có

  - 900,000 đồng nhiễm Lao/HIV

  - 217,000 người chết là Lao/HIV

- Hiện nay bệnh lao vẫn là một bệnh có nguy cơ cao nhất về số lượng người mắc, nhiễm bệnh và số người tử vong.
- Theo WHO có khoảng 1/3 dân số toàn cầu nhiễm lao, khoảng 8,8 triệu người mắc lao mới và 1,6 triệu người chết do lao, trong đó 195.000 người đồng nhiễm lao/HIV.
- Tỷ lệ tử vong do lao chiếm 25% trong tổng số tử vong do mọi nguyên nhân khác.

Gánh nặng cho chăm sóc y tế gia tăng Rủi ro nghề nghiệp gia tăng

- Ở Việt Nam, ước tính mỗi năm phát hiện khoảng 150.000 người mắc bệnh lao mới ở tất cả các thể lao
- Lao phổi là bệnh chính chiếm 85%, còn lại là mắc các loại lao khác như lao màng não, lao xương, lao khớp, lao da, lao hạch…
- Số người chết do lao hàng năm 20.000 người
- Số NVYT và người tiếp xúc với người bệnh tăng và các rủi ro tăng theo

TT LB 29 (25/12/1991)

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-bo-29-TT-LB-bo-sung-benh-nghe-nghiep-41336.aspx

1. Loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (Bệnh da nghề nghiệp do crom)
2. Bệnh xạm da nghề nghiệp
3. Bệnh rung chuyển nghề nghiệp
4. Bệnh bụi phổi bông
5. Bệnh lao nghề nghiệp
6. Bệnh viêm gan do virut nghề nghiệp
7. Bệnh do Leptospira nghề nghiệp
8. Bệnh nhiễm độc TNT

BỘ Y TẾ

Số: 15/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2016

QUY ĐỊNH VỀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi-319385.aspx

- 31. Bệnh **lao** nghề nghiệp và hướng dẫn chẩn đoán giám định quy định tại Phụ lục 31 ban hành kèm theo Thông tư này

PHỤ LỤC 31

- HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, GIÁM ĐỊNH SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG DO BỆNH **LAO** NGHỀ NGHIỆP
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Định nghĩa bệnh

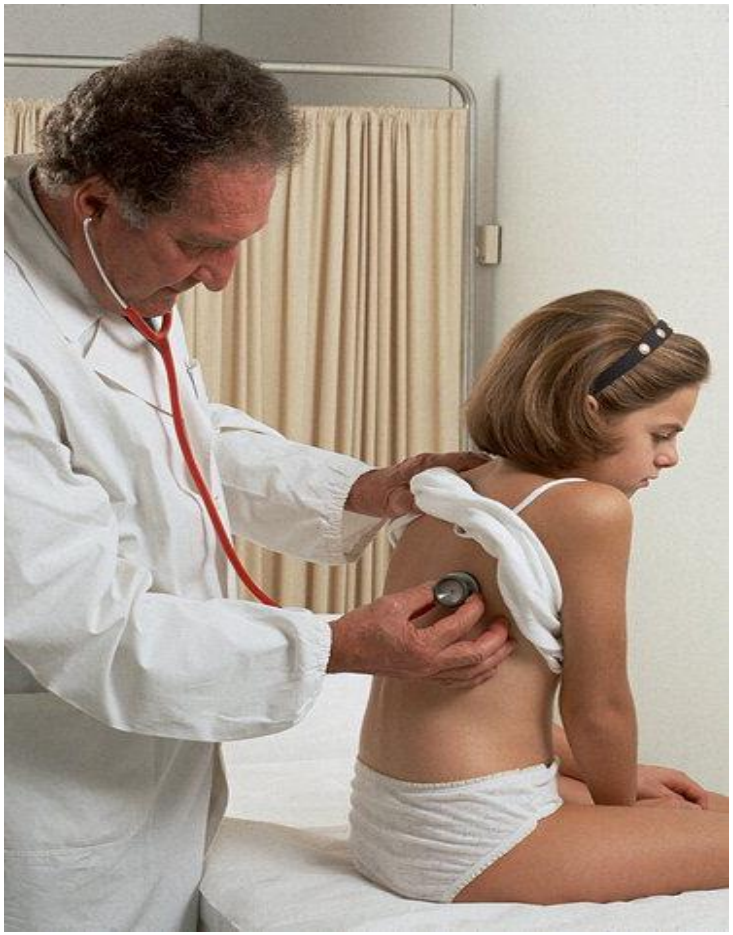
- Bệnh lao nghề nghiệp là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra trong quá trình lao động.

2. Yếu tố gây bệnh

- Vi khuẩn lao trong môi trường lao động

- **Nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc**
- - Nhân viên y tế;
- - Làm việc tại lò giết, mổ gia súc;
- - Thú y chăn nuôi gia súc;
- - Nghề/công việc khác tiếp xúc với vi khuẩn lao.

2. Bệnh Lao Người Nghề Nghiệp



Nguyên nhân và cách lây nhiễm lao người

- Nguyên nhân: do trực khuẩn Koch (do nhà vi trùng học người Đức Robert Koch phát hiện năm 1882 và gọi tắt là BK). Đây là một loại trực khuẩn hình que, sinh sản nhanh và bền vững.
- Trực khuẩn lao có thể sống vài tuần trong không khí và nước, nhưng khi bệnh nhân nhổ đờm xuống đất ẩm và nơi tối thì trực khuẩn lao lại tồn tại đến 2-3 tháng.
- Đường lây chủ yếu là qua đường hít thở (trực khuẩn có trong không khí do người bệnh khạc nhổ, ho, hắt hơi); Khi nói chuyện trực tiếp với người bệnh.

Quần thể VK lao trong cơ thể người bệnh: 4 dạng

- Dạng phân chia, sinh sản trong hang lao
- Tồn tại trong tế bào, đặc biệt trong đại thực bào
- Dạng bán ngủ (*semidormant*), có thể phân chia bất kỳ lúc nào khi có điều kiện
- Dạng ngủ *(dormant),* hầu như không phân chia

- Một bệnh nhân lao phổi mỗi ngày có thể ho khạc ra 1 - 7 nghìn triệu trực khuẩn lao.
- Khi vào cơ thể, BK khu trú ở nhu mô phổi là chính, 85-90% lao phát triển ở phổi, còn lại có thể gây lao màng não, xương khớp, hạch, thận, ruột, da.
- Do đó nói đến lao, người ta nghĩ ngay đến lao phổi. Người mang BK trong cơ thể, gọi là nhiễm lao, nếu hệ miễn dịch tốt có thể vẫn khỏe mạnh.
- Nhưng đến lúc, hệ miễn dịch suy giảm như mắc một bệnh khác (cảm cúm, tiểu đường, bụi silic phổi, HIV/AIDS...) thì nhiễm lao sẽ phát triển thành bệnh lao.

Chẩn đoán lao phổi nghề nghiệp

Giới hạn tiếp xúc tối thiểu

- Yếu tố gây bệnh được ghi nhận trong phần đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp của Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động.

Thời gian tiếp xúc tối thiểu

- 6 tháng.

Thời gian bảo đảm

- - Lao phổi, xương - khớp, tiết niệu - sinh dục: 1 năm;
- - Lao ruột, lao màng (não, tim, phổi, ruột, bao hoạt dịch), da, hạch: 6 tháng.

Lâm sàng và cận lâm sàng

- - Ho khúc khắc kéo dài, có khi khạc ra đờm hoặc trong đờm lẫn máu.
- - Cảm giác mỏi mệt toàn thân, chán ăn, sụt cân trong những tháng đầu.
- - Cứ về chiều lại hơi bị sốt, theo dõi thân nhiệt thấy sáng và chiều cách nhau khoảng nửa độ, ví dụ sáng 37oC, chiều 37,5oC kéo dài nhiều ngày.
- - Có trường hợp cảm thấy khó thở, tức ngực, có khi ho ra máu.
- - Nếu thấy ho khạc kéo dài trên ba tuần, uống thuốc ho thông thường không khỏi, kèm thêm mỏi mệt hoặc sốt nhẹ về chiều thì phải đi khám bệnh và làm xét nghiệm đờm tại bệnh viện.

Xét nghiệm xác định như:

- Mantoux, BCG
- Soi đờm tìm BK
- Chiếu hoặc chụp X-quang phổi,
- Đo chức năng hô hấp,
- Xét nghiệm đờm tìm BK là tiêu chuẩn quan trọng để điều trị sớm, tránh được lây lan sang những người chung quanh.

- **ĐỐI TƯỢNG CHẨN ĐOÁN**
- Người lao động có tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn lao người (hoặc lao bò) trong môi trường làm việc
- **TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN**

- CK BNN xác định **nguồn gốc bệnh do NN**
- CK Lao chẩn đoán xác định:
- **Cận lâm sàng:** Phản ứng Mantoux, BCG +, XN đờm BK +, X quang hình ảnh Lao phổi, màng phổi, X quang xương khớp (lao xương), sinh thiết hạch: hình ảnh hang lao, bã đậu

- **Triệu chứng lâm sàng:**
- Sốt nhẹ chu kỳ. Sốt về chiều (tối). Ra mồ hôi
- Chán ăn, gầy yếu, xút cân, suy giảm SK
- Ho khan, có đờm. Ho ra máu
- Đau ngực, khó thở, cảm giác chèn ép ngực
- Hội chứng 3 giảm: RRPN, Rung thanh, Gõ đục
- Ran ẩm, thổi hang, chọc dò: nc vàng chanh
- Các thể lao khác: lao xương (đau, hạn chế, biến dạng), hạch (sưng, bã đậu), da (u), tinh hoàn (to, nước trong mào tinh hoàn)

Phác đồ ĐT

Thuốc	Liều hàng ngày (mg/kg)	Liều cách quãng 3lần/tuần (mg/kg)
Isoniazid (H)	5 (4-6)	10 (8-12)
Rifampicin (R)	10 (8-12)	10 (8-12)
Pyrazinamide (Z)	25 (20-30)	35 (30-40)
Ethambutol (E)	15 (15-20)	30 (25-35)
Streptomycin (S)	15 (12-18)	15 (12-18)

Tác dụng từng loại thuốc
và kháng thuốc

- *Isoniazid:* Tiêu diệt khoảng 90% số VK lao trong vài tuần điều trị, tác dụng mạnh nhất đối với trạng thái Vk lao đang phân chia
- *Rifampicin:* Tiêu diệt VK lao cả ở trạng thái phân chia cũng như dạng bán ngủ (INH không tác dụng với trạng thái này)
- *Pyrazinamide:* Tiêu diệt VK lao ở môi trường acide (trong tế bào)
- *Streptomycin và Ethambutol:* Tác dụng diệt khuẩn hạn chế hơn
- *Isoniazid và Rifampicin:* Là 2 thuốc diệt khuẩn mạnh nhất

Lao ngoài phổi

7.2.1. Lao hạch ngoại vi

7.2.2. Tràn dịch màng phổi (TDMP) do lao

7.2.3. Tràn dịch màng tim (TDMT) do lao

7.2.4. Tràn dịch màng bụng (TDMB) do lao

7.2.5. Lao màng não-não

7.2.6. Lao xương khớp

7.2.7. Lao Tiết niệu - sinh dục

7.2.8. Các thể lao khác ít gặp hơn

lao da, lao lách, lao gan có thể phối hợp với lao phổi được chẩn đoán bằng sinh thiết để chẩn đoán mô bệnh tế bào.

7.2.1. Lao hạch ngoại vi

- Lâm sàng: Vị trí thường gặp nhất là hạch cổ, điển hình là dọc cơ ức đòn chùm, nhưng cũng có thể ở các vị trí khác. Hạch sưng to, lúc đầu hạch chắc, riêng rẽ, di động, không đau sau đó dính vào nhau và tổ chức dưới da, kém di động, hạch nhuyễn hóa, rò mủ. Có thể khỏi và để lại sẹo xấu.
- Chẩn đoán xác định: Sinh thiết hạch, chọc hút hạch xét nghiệm mô bệnh học, tế bào thấy chất hoại tử bã đậu, tế bào bán liên, tế bào lympho, nang lao; nhuộm soi trực tiếp tìm thấy AFB; ngoài ra có thể tìm vi khuẩn lao bằng phương pháp nuôi cấy bệnh phẩm chọc hút hạch.

7.2.2. Tràn dịch màng phổi (TDMP) do lao

- Triệu chứng lâm sàng: Đau ngực, khó thở tăng dần, khám phổi có hội chứng 3 giảm.
- X-quang ngực thấy hình mờ đậm thuần nhất, mất góc sườn hoành, đường cong Damoiseau. Siêu âm màng phổi có dịch.
- Chẩn đoán xác định: Chọc hút khoang màng phổi thấy dịch màu vàng chanh, rất hiếm khi dịch màu hồng, dịch Tiết, ưu thế thành phần tế bào lympho; có thể tìm thấy bằng chứng vi khuẩn lao trong dịch màng phổi bằng nhuộm soi trực tiếp và nuôi cấy. Sinh thiết màng phổi mù hoặc qua soi màng phổi để lấy bệnh phẩm chẩn đoán vi khuẩn học hoặc mô bệnh tế bào.

7.2.3. Tràn dịch màng tim (TDMT) do lao

- Triệu chứng lâm sàng: Các triệu chứng phụ thuộc vào số lượng dịch và tốc độ hình thành dịch màng tim. Triệu chứng thường gặp bao gồm: đau ngực, khó thở, tĩnh mạch cổ nổi, phù chi dưới. Khám có tim nhịp nhanh, huyết áp kẹt, mạch đảo ngược nếu có hội chứng ép tim cấp. Nghe có tiếng cọ màng tim ở giai đoạn sớm hoặc tiếng tim mờ khi tràn dịch nhiều.
- X-quang ngực thấy bóng tim to, hình giọt nước, hình đôi bờ. Điện tim có điện thế thấp ở các chuyển đạo, sóng T âm và ST chênh. Siêu âm có dịch màng ngoài tim.
- Chẩn đoán xác định: Chọc hút dịch màng tim, dịch thường màu vàng chanh, dịch Tiết, tế bào lympho chiếm ưu thế. Có thể tìm thấy bằng chứng vi khuẩn lao trong dịch màng tim bằng nhuộm soi trực tiếp và nuôi cấy.

7.2.4. Tràn dịch màng bụng (TDMB) do lao

- Triệu chứng lâm sàng: Có các dấu hiệu tràn dịch màng bụng như gõ đục vùng thấp thay đổi theo tư thế, “sóng vồ”, dấu hiệu gõ đục “ô bàn cờ” giai đoạn muộn. Có thể sờ thấy các u cục, đám cứng trong ổ bụng. Có thể có dấu hiệu tắc hoặc bán tắc ruột do các hạch dính vào ruột.
- Siêu âm ổ bụng có các hình ảnh gợi ý lao màng bụng: hạch mạc treo to, hạch sau màng bụng, dịch khu trú giữa các đám dính, *nội soi ổ bụng* thấy các hạt lao.
- Chẩn đoán xác định: Chọc hút dịch màng bụng màu vàng chanh, đôi khi đục, dịch Tiết, tế bào lympho chiếm ưu thế. Có thể tìm thấy bằng chứng vi khuẩn lao trong dịch màng bụng bằng nhuộm soi trực tiếp, nuôi cấy. Soi ổ bụng và sinh thiết là kỹ thuật rất có giá trị cho chẩn đoán trong hầu hết các trường hợp. Trên tiêu bản sinh thiết thấy hoại tử bã đậu, nang lao.

7.2.5. Lao màng não-não

- Triệu chứng lâm sàng: Bệnh cảnh viêm màng não khởi phát bằng đau đầu tăng dần và rối loạn tri giác. Khám thường thấy có dấu hiệu cổ cứng và dấu hiệu Kernig (+). Có thể có dấu hiệu tổn thương dây thần kinh sọ não và dấu hiệu thần kinh khu trú (thường liệt dây 3, 6, 7, rối loạn cơ tròn). Các tổn thương tủy sống có thể gây ra liệt 2 chi dưới (liệt cứng hoặc liệt mềm).
- Chọc dịch não tủy áp lực tăng, dịch có thể trong (giai đoạn sớm), ánh vàng (giai đoạn muộn), có khi vẩn đục. Xét nghiệm sinh hóa dịch não tủy thường thấy protein tăng và đường giảm. Tế bào trong dịch não tủy tăng vừa thường dưới 600 tế bào/mm^3 và tế bào lympho chiếm ưu thế, ở giai đoạn sớm tỷ lệ neutro tăng nhưng không có bạch cầu thoái hóa (mủ).
- Chẩn đoán xác định: Dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, đặc Điểm dịch não tủy và xét nghiệm sinh hóa tế bào dịch não tủy, có thể tìm thấy bằng chứng vi khuẩn lao trong dịch màng não bằng nuôi cấy (tỷ lệ dương tính cao hơn khi nuôi cấy trên môi trường lỏng) hoặc các phương pháp mới như Xpert MTB/RIF, nhuộm soi trực tiếp AFB (+) với tỷ lệ rất thấp.
- Chụp MRI não có thể thấy hình ảnh màng não dày và tổn thương ở não gợi ý lao, ngoài ra chụp MRI não giúp chẩn đoán phân biệt bệnh lý khác ở não như u não, viêm não, áp xe não, sán não.
- Chẩn đoán loại trừ với các căn nguyên khác như: viêm màng não mủ, viêm màng não nước trong và các bệnh lý thần kinh khác.

7.2.6. Lao xương khớp

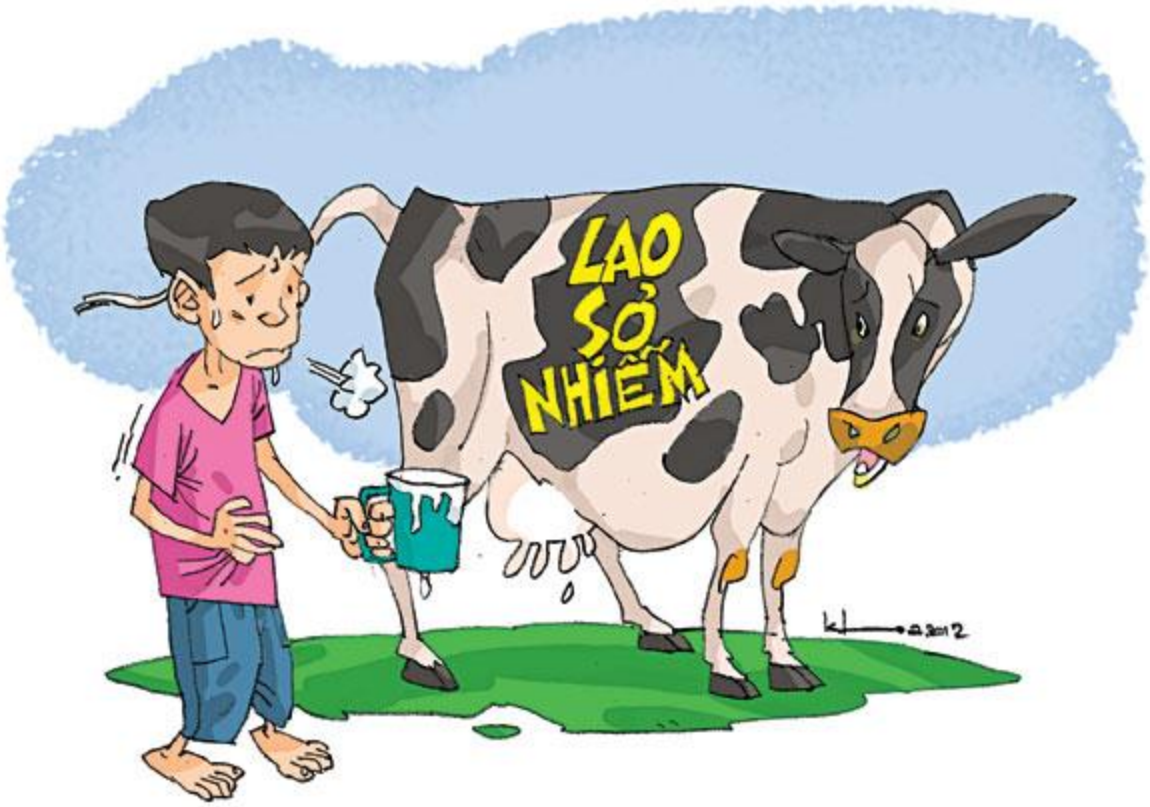
- Triệu chứng lâm sàng: Hay gặp ở cột sống với đặc Điểm: đau lưng, hạn chế vận động, đau tại chỗ tương ứng với đốt sống bị tổn thương (giai đoạn sớm); giai đoạn muộn gây biến dạng gù cột sống hoặc có dấu hiệu chèn ép tủy gây liệt.
- Ngoài cột sống lao còn hay gặp ở các khớp lớn với biểu hiện: sưng đau khớp kéo dài, không sưng đỏ, không đối xứng, có thể dò mủ bã đậu.
- Chụp Xquang, CT, MRI cột sống, khớp thấy hẹp khe đốt, xẹp đốt sống hình chêm, có thể thấy mảnh xương chết và hình áp xe lạnh cạnh cột sống, hẹp khe khớp.
- Chẩn đoán xác định: Dựa vào lâm sàng và các đặc Điểm tổn thương trên Xquang, CT, MRI cột sống, khớp. Nếu có áp xe lạnh, dò mủ xét nghiệm mủ áp xe tìm AFB cho tỷ lệ dương tính cao. Sinh thiết tổ chức cho phép chẩn đoán mô bệnh tế bào.

7.2.7. Lao Tiết niệu - sinh dục

- Lâm sàng: Hay gặp triệu chứng rối loạn bài Tiết nước tiểu (đái buốt, đái dắt) kéo dài từng đợt, Điều trị kháng sinh đỡ sau đó lại bị lại, có thể đái máu không có máu cục, đái đục, đau thắt lưng âm ỉ.
- Lao sinh dục nam: Sưng đau tinh hoàn, mào tinh hoàn, ít gặp viêm cấp tính, tràn dịch màng tinh hoàn.
- Lao sinh dục nữ: Ra khí hư, rối loạn kinh nguyệt, dần dần “mất kinh”, vô sinh.
- Chẩn đoán xác định: Tìm thấy vi khuẩn lao trong nước tiểu, dịch màng tinh hoàn, dịch dò, khí hư bằng nuôi cấy (tỷ lệ dương tính cao hơn khi cấy trên môi trường lỏng), nhuộm soi trực tiếp AFB (+) với tỷ lệ rất thấp. Chụp UIV thấy hình ảnh gợi ý lao như đài thận cắt cụt, hang lao, niệu quản chít hẹp. Soi bàng quang, soi tử cung và sinh thiết xét nghiệm mô bệnh, tế bào có nang lao, xét nghiệm vi khuẩn lao. Chọc hút dịch màng tinh hoàn (có đặc Điểm như lao các màng khác trong cơ thể), chọc dò “u” tinh hoàn xét nghiệm tế bào có viêm lao.

3. Bệnh lao bò nghề nghiệp

Nguy cơ mắc lao từ sữa bò



- - Trên bò và nhiều động vật có vú khác (trâu, ngựa, lừa, dê, cừu, chó, mèo, thỏ …chuột)
- - Đường truyền: chủ yếu – đường tiêu hóa, các đường khác ít gặp hơn
- - Đối tượng nguy cơ mắc: Nhân viên thú y, nhân viên tiếp xúc với súc vật trên

© Reuters

2014
© Reuters

Dự phòng bệnh Lao nghề nghiệp

4. Quản lý - Dự phòng bệnh lao nghề nghiệp

- Quản lý - DP bằng trang bị an toàn
- Quản lý - DP bằng các biện pháp y tế
- Quản lý - DP bằng truyền thông GDSK

Tẩy uế các vật dụng nhiễm máu hay huyết thanh

- Dùng hóa chất: một dung dịch 0,5% hypochlorit Na. Dung dịch này được pha chế hàng ngày và phải được thử hiệu quả, dùng giấy iod (màu xanh lục sẫm). Đối với dụng cụ kim loại, dùng dung dịch 2% aldehyd glutaric thích hợp hơn vì không bị ăn mòn. Khăn trải giường, quần áo lót phải ngâm vào dung dịch 1,5% formalin trong 12 giờ.
- Đun sôi trong 20-30 phút cũng có tác dụng.
- Sử dụng tủ xấy ở 180oC, ít nhất trong 30 phút
- Hơi nước nóng 120oC dưới áp lực 1 bar trong 15 phút.

Giám định

(Chi tiết xem PL 31-TT15/2016/BYT)

Những công việc có thể gây bệnh:

- - Công việc phải tiếp xúc với bệnh nhân lao.
- - Công việc trong các phòng thí nghiệm vi khuẩn ở các bệnh viện lao. Công việc lấy bệnh phẩm: đờm, máu, phân, tiếp xúc với chất thải hoặc đồ đạc bị nhiễm bệnh.
- Công việc phải tiếp xúc với súc vật bị bệnh lao hoặc mang vi khuẩn lao.
- - Công việc trong lò sát sinh, các cửa hàng bán thịt.
- - Các thao tác xử lý máu, xương, sừng, da súc vật.
- - Công tác thú y.

Chẩn đoán xác định dựa vào lâm sàng, X quang, xét nghiệm vi sinh vật, giải phẫu bệnh lý... tuỳ theo các thể bệnh.

Chi tiết: Xem Phụ lục 31-TT 15/2016/BYT

Hội chứng bệnh	Thời gian bảo đảm	Tỷ lệ mất khả năng lao động
- Bệnh lao da	6 tháng	21-40%
- Bệnh lao hạch	6 tháng	21-40%
- Lao màng hoạt dịch	1 năm	21-40%
- Lao xương khớp	1 năm	31-60%
- Lao màng phổi	6 tháng	31-60%
- Lao phổi	6 tháng	31-60%

Bài tập tình huống 1

Chị Lâm, 40 tuổi làm lao động nông nghiệp ở Thái Bình giọng buồn kể "Dạo trước tôi thấy trong người mệt mỏi, thường xuyên ho, tức ngực khó thở, thi thoảng có hơi sốt thường là vào buổi chiều. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình mắc bệnh cảm cúm nên ra hiệu thuốc gần nhà mua vài viên thuốc ngậm trị ho, giảm sốt thông thường.

Nhưng bệnh vẫn kéo dài hàng tuần không khỏi. 2 tuần trước thỉnh thoảng tôi lại ho ra máu. Sợ quá tôi vội vàng đi khám tại cơ sở y tế gần nhà thì các bác sĩ cho biết có dấu hiệu nhiễm khuẩn lao và khuyên tôi nên lên tuyến trên để khám chữa cho hiệu quả.

Sáng hôm qua tôi bắt xe từ quê ra Hà Nội, sáng nay đi khám sớm. Tôi lo quá, không biết mình có đúng bị lao không? Nếu bị thì khổ quá. Tôi sợ mình sẽ lây bệnh cho con cái trong nhà thì chết…". Theo anh (chị) thì

- Chị Lâm có bị lao không?
- Có lời khuyên gì với chị Lâm

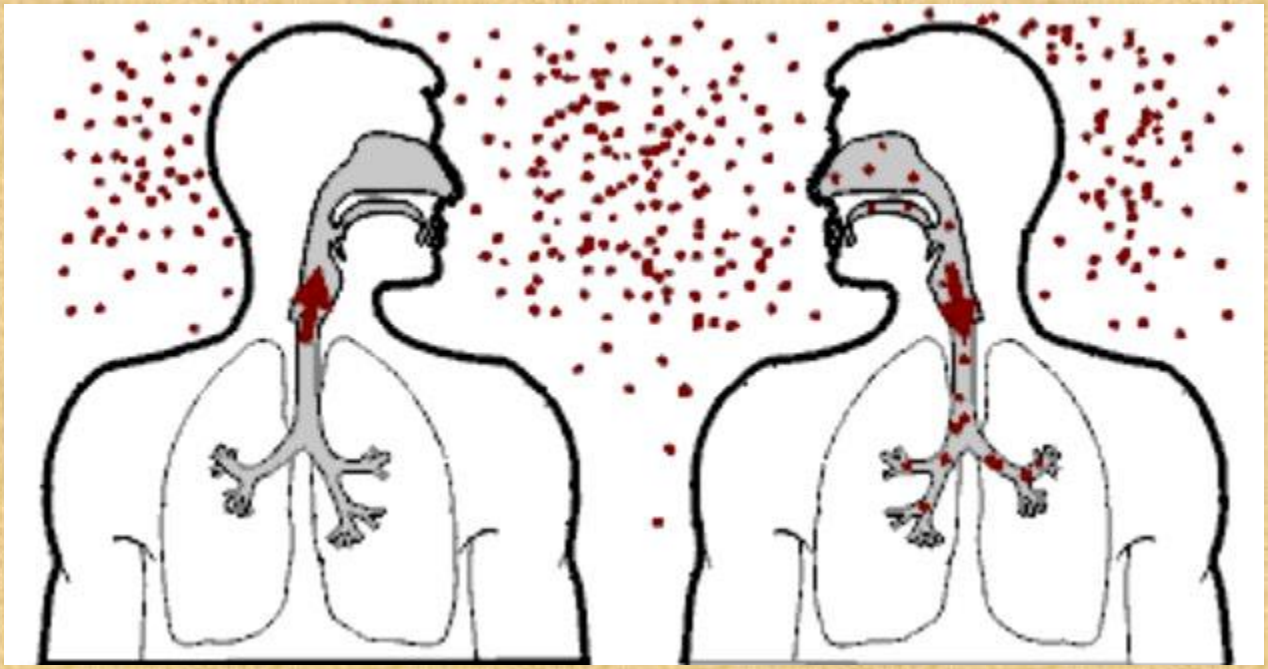
Bài tập tình huống 2

Anh Tuấn, 37 tuổi, công nhân toa xe Đông Anh, Hà Nội kể chuyện với khuôn mặt hốc hác. Anh kể bác sĩ đã thông báo anh không còn hy vọng chữa khỏi. Anh rất hoang mang. Là trụ cột trong nhà, nay anh bệnh thế này một mình vợ làm sao vừa nuôi chồng ốm vừa nuôi mẹ già và 2 đứa con gái nhỏ?

Anh cho biết đây là lần thứ 3 anh nhập viện điều trị.

Cách đây hơn 1 năm anh Tuấn đã nhập viện điều trị khi biết mình mắc bệnh lao phổi. Các bác sĩ đã cho anh uống một số loại thuốc đặc trị và bệnh anh dần dần giảm. Khi không còn dấu hiệu ho, tức ngực anh xin xuất viện về nhà điều trị tại nhà. Nhưng vì lo làm ăn và do chủ quan tưởng mình đã hết bệnh nên anh Tuấn không tiếp tục uống thuốc. 6 tháng sau khi xuất viện, anh Tuấn lại thấy trong người khó chịu, những cơn ho tái phát ngày càng nhiều hơn trước.

Lúc này, anh Tuấn mới vội đến bệnh viện tái khám thì các bác sĩ điều trị cho biết anh đã nhiễm loại khuẩn lao kháng thuốc. Các bác sĩ trong khoa cũng cho anh biết thường chỉ có 50% bệnh nhân nhiễm lao kháng thuốc có cơ hội khỏi bệnh và quá trình chạy chữa sẽ rất tốn kém. Anh (chị) cho biết

- Tình hình anh Tuấn hiện tại là như thế nào?
- Lời khuyên gì cho a Tuấn?

HẾT BÀI – ĐỌC THÊM – CÂU HỎI